

PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO PARA INSERÇÃO/RETIRADA DE IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL

Versão 3/2025 – 08/12/2025

1. APRESENTAÇÃO

O seguinte protocolo tem por objetivo orientar sobre a inserção/retirada do método contraceptivo “Implante Subdérmico Liberador de Etonogestrel” e o fluxo de encaminhamento para a Policlínica Central, a partir do encaminhamento realizado pela rede de Atenção Primária à Saúde (APS) do município de Santa Maria - RS.

2. FLUXO DE ENCAMINHAMENTO DA APS AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Os encaminhamentos devem ocorrer através do Sistema SIGSS MV, por meio de consulta médica ou de enfermagem, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de referência dos usuários, utilizando o CBO: PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, entrando para a lista de espera da regulação municipal. A regulação municipal, por sua vez, realizará a avaliação de cada caso a partir das informações clínicas prestadas, bem como, os CIDs utilizados para encaminhamento, podendo ou não alterar a classificação, bem como devolver ou negar o encaminhamento conforme informações e/ou CIDs utilizados e em consonância com este protocolo.

Após regulação médica, o encaminhamento poderá ser direcionado ao serviço especializado, conforme agenda disponível: Policlínica Central (Rua Venâncio Aires, 2035, 8º andar, Edifício da CACISM).

Para realizar o encaminhamento para inserção do implante subdérmico de etonogestrel, o profissional médico(a) ou enfermeiro(a), durante a consulta, **deverá avaliar as contraindicações** para escolha do método contraceptivo e utilizar os seguintes dados, sendo o caráter de encaminhamento (normal/urgência) conforme avaliação clínica do profissional assistente:

- **CBO:** PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
- **UNIDADE DESEJADA:** POLICLÍNICA CENTRAL

- **CID:** Procedimento anticoncepcional não especificado (Z30.9)

Após regulação médica, o profissional médico (a) ou enfermeiro (a) deverá imprimir, assinar e entregar a guia de autorização, orientando o(a) paciente a levá-la no dia da consulta médica.

3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA RECOMENDAÇÃO E INSERÇÃO DO IMPLANTE SUBCUTÂNEO LIBERADOR DE ETONOGESTREL

O método pode ser ofertado para todas as pessoas com útero em idade reprodutiva de 10 a 49 anos, que tenham apresentado menarca e que não possuam contraindicações ao método.

4. CONTRAINDICAÇÕES AO MÉTODO

Critérios de elegibilidade para uso do implante subdérmico contraceptivo

Categoria 1: O método pode ser usado sem restrições.

Categoria 2: O método pode ser usado. Benefícios superam riscos.

Categoria 3: O método não deve ser usado. Caso seja usado, deve ser o método de última escolha, com acompanhamento rigoroso.

Categoria 4: O método não deve ser usado. Risco inaceitável.

4.1 Contraindicação absoluta - categoria 4

- Suspeita ou diagnóstico de gravidez;
- Câncer de mama atual e demais neoplasias sensíveis a esteróides sexuais. O histórico familiar não contraindica.

4.2 Contraindicação relativa - categoria 3

- Sangramento genital irregular não investigado (quando não for possível afastar uma gestação);
- Tromboembolismo venoso agudo na ausência de anticoagulação;
- Infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral em vigência de uso do método (o histórico destas condições é classificado como categoria 2);
- Enxaqueca com aura durante o uso do método (se for prévia, não há

contraindicação);

- Adenoma hepatocelular, adenocarcinoma hepatocelular, cirrose hepática severa;
- Câncer de mama tratado há mais de cinco (5) anos;
- Lúpus eritematoso sistêmico com positividade para anticorpos antifosfolípidos;
- Hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer outro componente do implante subdérmico.

CONDIÇÃO CLÍNICA DA PACIENTE	CATEGORIA PARA USO DO IMPLANTE
48 horas a 4 semanas pós-parto	2
Imediato pós-aborto	1
Neoplasia trofoblástica gestacional	1
LES com anticorpo antifosfolípide positivo	3
TEV agudo sem uso de anticoagulação	3
IAM, AVC e enxaqueca com aura durante uso do método	3
Histórico de IAM, AVC ou TEV	2
Adenoma hepatocelular, adenocarcinoma hepatocelular, cirrose hepática severa	3
Hepatite viral aguda	1
Sangramento vaginal inexplicado quando não é possível afastar gestação	3
Mioma com distorção da cavidade uterina, anormalidades anatômicas, DIP atual, TB pélvica	1
Câncer de colo	2
Câncer de mama atual	4
Câncer de endométrio	1
Câncer de mama sem evidências de doença ativa por 5 anos	3

CATEGORIAS



World Health Organization (WHO). Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5th ed. Geneva: WHO; 2015.

NTG: neoplasia trofoblástica gestacional; BHCG: gonadotrofina coriônica humana; LES: lúpus eritematoso sistêmico; AVC: acidente vascular cerebral; IAM: infarto agudo do miocárdio; TEV: tromboembolismo venoso; DIP: doença inflamatória pélvica; TB: tuberculose.

5. SOLICITAÇÃO DE ABASTECIMENTO, CONTROLE DO ESTOQUE E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO

Os serviços especializados (Policlínica Central), ficam responsáveis por realizar a solicitação do material necessário junto à Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). Conforme previsão quantitativa de procedimentos a serem agendados, irão realizar o controle do estoque e o armazenamento dos dispositivos

em local adequado, observando que estes devem ser mantidos em temperatura ambiente, protegidos da luz e da umidade. Atentar para nº de lote, datas de fabricação e validade.

6. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O profissional médico(a) que realizará o procedimento nos serviços especializados, deverá orientar sobre o método e oferecer o **TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)**, coletando a assinatura da usuária e permanecendo uma via do termo com o serviço de saúde. O documento pode ser acessado no Anexo I deste protocolo.

7. INSERÇÃO E REMOÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL

O implante será realizado por profissional médico(a), podendo ser inserido até 5 dias após o início da menstruação (para garantir que não há gravidez). É eficaz logo após a colocação, sendo colocado na parte interna do braço, preferencialmente o não dominante, debaixo da pele, como se fosse uma injeção. É necessária anestesia no local para inserção do implante. A colocação do implante subdérmico é permitida fora do ambiente hospitalar, sem a necessidade do médico anestesista, sendo o médico assistente o profissional responsável por sua aplicação. Pode ocorrer alguma dor, edema, equimose ou hematoma pequeno no local da colocação, porém são situações auto limitadas. O implante é removido no máximo 3 anos após a sua inserção, ou antes, se for a pedido.

8. ORIENTAÇÕES

- Recomenda-se as seguintes orientações pós procedimento à pessoas que desejam utilizar o implante (também disponíveis no Anexo II deste documento):
- Podem ocorrer algumas alterações da pele, dores de cabeça, náuseas, aumento da sensibilidade mamária e variações do humor (semelhantes às que ocorrem com outros métodos contraceptivos como a pílula);
- Na maioria dos casos, há sangramento irregular, podendo haver aumento do fluxo menstrual ou ausência de menstruação. Estas alterações são mais comuns nos primeiros 4 a 6 meses até o primeiro ano e não têm consequências negativas na saúde;
- Irregularidade é diferente de falha do método;
- Descartar outras doenças, se sangramento com mais de 6 meses ou dispareunia ou dor pélvica associada. Nestes 3 casos, solicitar USTV (Ultrassonografia transvaginal).

9. REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Procedimentos / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 64 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Primária, n. 30). Nota: O título da série desta publicação passou a ser chamado de Cadernos de Atenção Primária, a partir do número 28.

Brasil. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único De Saúde (CONITEC). Relatório de recomendação - medicamento. Implante subdérmico de etonogestrel na prevenção de gravidez não planejada por mulheres adultas em idade reprodutiva entre 18 e 49 anos. Brasília: Ministério da Saúde, Abr. 2021. N. 599, 84 p.

Critérios Médicos de Elegibilidade para Uso de Métodos Anticoncepcionais. OMS
<https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340375131Portuguese-AppendixD.pdf>
f

IMPLANON NXT®. [Bula]. Campinas, SP: N.V. Organon - Oss, Holanda. Disponível em:
https://www.organon.com/brazil/wp-content/uploads/sites/33/2023/06/implanon_NXT_bula_paciente.pdf. Acesso em: 06 de maio de 2025.

Secretaria Municipal da Saúde. Departamento de Planejamento em Saúde. Coordenadoria de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Atenção aos Métodos Contraceptivos de Longa Duração (LARCs)/ Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Secretaria Municipal da Saúde. Departamento de Planejamento em Saúde. Coordenadoria de Assistência Integral à Saúde da Mulher. 2. Versão, Ribeirão Preto, 2022. 67 p.: il.- (Protocolos de Assistência Integral à Saúde da Mulher). Disponível em: <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/saude559202202.pdf>. Acesso em: 06 de maio de 2025.

Prefeitura de São Paulo. Secretaria Municipal da Saúde. Protocolo do implante subdérmico de etonogestrel para atendimento às pessoas vulneráveis. São Paulo: Secretaria Executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde, 2023.

ELABORADO POR:

Bruna Dedavid da Rocha
Enfermeira responsável pela Política de Saúde da Mulher

Dr. Renato Holkem Bonafé
Médico de Família e Comunidade

REVISADO POR:

Dra. Flávia Frazzon
Médica Reguladora - SMS

Enfermeira Juliana Pruni
Superintendente de Atenção Especializada - SMS

Farmacêutica Narla
Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - SMS

APROVADO POR:

**GUILHERME
RIBAS SMIDT
01654510092**

Assinado digitalmente por GUILHERME RIBAS
SMIDT 01654510092
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A3, OU=Videoconferencia,
OU=30722213000198, OU=AC SyngularID
* Multipia, CN=GUILHERME RIBAS SMIDT,
* 01654510092
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.08 09:24:29 -05'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

GUILHERME RIBAS SMIDT
Secretário de Município da Saúde
Portaria nº 4559/SAGP/2024

ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA INSERÇÃO DE IMPLANTE CONTRACEPTIVO DE ETONOGESTREL

Eu _____ RG _____
CPF _____ com _____ anos de idade, consinto que o médico(a)
_____ CRM _____ realize em mim o procedimento
de inserção de implante contraceptivo de etonogestrel.

Compreendo que o implante contraceptivo é um pequeno tubo de plástico, de cerca de 4 centímetros de comprimento por 2 milímetros de largura contendo um progestagênio (hormônio), chamado etonogestrel e é colocado debaixo da pele do braço que você não escreve (braço não dominante). Quem realiza a colocação é um médico treinado e habilitado para tanto. A ação do implante é contínua por 3 anos e acontece com a liberação do hormônio etonogestrel para o sangue da mulher, e funciona principalmente de dois modos: impede a ovulação e espessa o muco do colo do útero, o que dificulta a passagem dos espermatozoides para o útero. O implante tem eficácia superior a 99%, igual ou superior a eficácia da laqueadura tubária (5 gravidezes em 10.000 mulheres que usem o implante).

Compreendi ainda que as principais vantagens do implante são:

- É um método prático e de longa duração (3 anos).
- Evita ter que tomar a pílula todos os dias.
- Não interfere com a relação sexual.
- Não interfere com a amamentação.
- Melhora as cólicas menstruais.
- Pode ser usado pelas mulheres que não podem tomar pílulas contendo estrogênio.
- Não diminui a massa óssea (osteoporose).

Também foram a mim apresentadas as desvantagens desse método:

- Irregularidades da menstruação. Na maioria dos casos, há sangramento irregular, podendo haver aumento do fluxo menstrual ou ausência de menstruação. Essas alterações são mais comuns no primeiro ano, sendo que a cada 100 mulheres, 15 podem ter sangramento mais frequente.
- Pode ocorrer algumas alterações da pele, dores de cabeça, enjoos, aumento da sensibilidade mamária e variações do humor (semelhantes às que ocorrem com outros métodos contraceptivos como a pílula).
- Podem aparecer cistos benignos nos ovários, que geralmente não necessitam de tratamento.

Foi informado a mim também que o implante pode ser colocado até 5 dias após o início da sua menstruação (para garantir que não há gravidez). Nas puérperas (mulheres que tiveram parto recente), pode ser colocado imediatamente após o parto a depender do desejo da mulher. É eficaz logo após a colocação.

É colocado na parte interna do braço, debaixo da pele, como se fosse uma injeção. É necessária anestesia no local para inserção do implante. Pode ocorrer alguma dor, algum inchaço ou hematoma pequeno no local da colocação, mas passa rapidamente.

É removido 3 anos após a sua inserção, ou antes, se a seu pedido. Para a remoção do implante, também é preciso ser aplicada a anestesia.

ANEXO II - ORIENTAÇÕES PÓS PROCEDIMENTO

ORIENTAÇÕES PÓS INSERÇÃO DE IMPLANON

- Protege contra a gravidez por **até 03 (três) anos**
- **Não protege contra infecções sexualmente transmissíveis**
- Há o retorno da ovulação e da menstruação após 03 (três) meses da remoção em mais de 90% das mulheres.
- Durante o uso do Implanon, as mulheres ficam suscetíveis a **mudanças no padrão de sangramento menstrual** que podem incluir alterações na frequência (ausente, menos frequente, mais frequente ou contínua), na intensidade (reduzida ou aumentada) ou na duração do sangramento.
- A **ausência de menstruação** foi relatada por aproximadamente 1 a cada 5 mulheres, enquanto 1 a cada 5 mulheres relatou sangramento frequente e/ou prolongado. Ocasionalmente, sangramento intenso tem sido relatado.
- A dor da menstruação tende a melhorar durante o uso do Implanon. O padrão de sangramento durante os três primeiros meses é sugestivo do padrão de sangramento futuro para muitas mulheres.
- Medicamentos que podem **reduzir a eficácia** do Implanon: fenitoína, fenobarbital, primidona, bosentana, carbamazepina, rifampicina e, possivelmente também, oxcarbazepina, topiramato, felbamato, griseofulvina, alguns inibidores da protease do HIV (por exemplo, ritonavir, nelfinavir, nevirapina) e inibidores não-nucleosídeo da transcriptase reversa (por exemplo, efavirenz), medicamentos utilizados no tratamento de hepatite C (por exemplo, boceprevir, telaprevir), e produtos fitoterápicos contendo *Hypericum perforatum* – erva-de-são-jão ou St. John's wort. Os anticoncepcionais hormonais podem interferir no metabolismo de outros medicamentos e, conseqüentemente, as concentrações plasmáticas e tissulares podem ser aumentadas (por exemplo, ciclosporina) ou diminuídas (por exemplo, lamotrigina). **Se for decidido continuar com o uso do Implanon**, as mulheres devem ser orientadas a utilizar, adicionalmente, um método anticoncepcional não-hormonal durante o tempo de administração concomitante do medicamento e por 28 dias após a descontinuação.